Établissement

Médecin responsable

PROTOCOLE DE SOINS INFIRMIERS D'URGENCE — ARTICLE R.4311-7 CSP

Surveillance traumatisme crânien

Adulte et enfant · surveillance sur place seulement si elle est possible pendant 24 h

URGENCE VITALE → 15 IMMÉDIAT · GCS < 15 à 2 h ou en baisse ; convulsion, déficit, anisocorie ; **> 1 vomissement** ; céphalée croissante ; somnolence ; liquide clair (nez, oreille), hématome en lunettes ; amnésie > 30 min ; intoxication.

J'applique si

- Choc crânien observé ou suspecté, y compris chez une personne non communicante.
- Aucun signe du bandeau rouge, et surveillance de 24 h possible.

Je n'applique pas → 15 ou avis

- **Anticoagulant**, deux antiagrégants, trouble de l'hémostase : **15** (scanner dans l'heure).
- **≥ 65 ans sous un antiagrégant** : avis ou 15 sans délai (scanner dans les 8 h).
- Cervicalgie : **ne pas mobiliser la tête**, 15.
- Surveillance impossible (nuit sans personnel, état habituel inconnu).

J'agis

ACTES CONSERVATOIRES (R4311-7)

1. Heure, mécanisme, perte de connaissance, amnésie ; **GCS, pupilles, 4 membres** vs état habituel.
2. FC, PA, SpO2, **glycémie** ; anticoagulant, antiagrégant.
3. Surveillance selon la **grille** ci-contre ; **la nuit, réveiller** aux heures prévues.
4. Toute détérioration : revenir à 30 min, **15**, préparer le DLU.

RÔLE PROPRE

5. Plaie : compression, pansement (pas de colle au cuir chevelu) ; froid local protégé.
6. Douleur : **paracétamol** (son protocole) ; **ni AINS ni aspirine**.

SUR ORDRE DU 15

7. Transfert, maintien sur place malgré un critère, antalgique autre que le paracétamol.

Consigne orale du 15 ou du médecin → télé-prescription écrite, annexée au dossier.

Grille (NICE)

Toutes les 30 min pendant 2 h

Toutes les heures pendant 4 h

Toutes les 2 h jusqu'à 24 h

- À chaque passage : GCS, pupilles, 4 membres, FR, FC, PA, SpO2, T°, céphalée, vomissements
- Enfant, non communicant : cris, refus, somnolence = signes neurologiques

J'appelle le médecin

- Tout choc crânien : médecin informé le jour même.
- Un vomissement, bosse, plaie ; céphalée ou confusion les jours suivants.

Je surveille et je trace

- Grille remplie à l'heure réelle, transmise à chaque relève.
- AS/AES : grille d'éveil (fiche AS « Traumatisme crânien »).
- **Compte rendu écrit, daté, signé**, remis au médecin (R4311-7).

À retenir : La surveillance ne remplace pas le scanner quand il est indiqué. Tout changement neurologique ou de comportement est une aggravation.

Fait à : .....

Le : ..... / ..... / .....

Signature et cachet du médecin :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : Art. R4311-7 CSP ; SFMU, RPP « Traumatisme crânien léger » (2022) ; NICE NG232, Head injury (18/05/2023), rec. 1.9.10-1.9.12 ; fiche DOTR AS « Traumatisme crânien » (2026).

Réf. DOTR-IDE-TC | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature